

DALIA GUTIÉRREZ

A principios de abril de 2017, un equipo de médicos en Monterrey se preparaba para concretar un hito histórico en México: el primer trasplante doble de pulmón, es decir, de ambos pulmones.

En el País sólo se habían realizado algunos procedimientos de un solo órgano, muchos sin éxito.

Al regío Mauricio Zapiain Martínez, entonces de 47 años, una enfermedad que había destruido casi por completo sus pulmones le había dado una sentencia de muerte.

“Fue un caso difícil, presentó todas las complicaciones que un trasplante puede tener”, recuerda Manuel Wong, cirujano de tórax y trasplante que estuvo al frente del procedimiento, realizado en Christus Muguerza Sur.

“Habíamos sido puestos a prueba con un caso difícil y habíamos salido adelante”.

Mauricio, quien falleció a finales de 2025, no sólo logró extender su vida por casi nueve años, un periodo superior a la media de sobrevida en pacientes con este tipo de trasplante.

También fue el punto de partida para consolidar el Programa de Trasplante Pulmonar del Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad, pionero y único en su tipo hasta la fecha en México.

Aunque hay otros hospitales del País que ya realizan estos procedimientos, ninguno ha consolidado un programa similar.

Al frente están el cirujano Wong; los neumólogos Uriel Chavarría y Sergio Saúl Sánchez; la enfermera Irma de Osio, y el anestesiólogo Vicente Fuentes Puga, junto con más de una decena de especialistas de otras áreas.

Con este programa, más de 50 personas de México han recibido una segunda oportunidad de vida.

Detrás hay médicos decididos que, desde que parecía inalcanzable, estaban convencidos de que podían cambiar paradigmas.

“Para nosotros, el trasplante pulmonar es un propósito de vida. Es a lo que vinimos al mundo”, expresa el neumólogo Chavarría, director médico del programa.

“Es tener a alguien platicándome que acaba de ir a la playa, después de que su destino era morir”.

SENTARSE a conversar con los líderes del equipo es como estar en una plática entre amigos de toda la vida que, entre bromas, nostalgia y solemnidad, recuerdan sus inicios en el Hospital Universitario.

El médico Chavarría y la enfermera De Osio fueron de los primeros en ser invitados a entrenarse en el extranjero para trasplante pulmonar, a mediados de los años 90.

“Comenzamos a preparar pacientes y dábamos pláticas a las enfermeras, pero no había donadores”, recuerda De Osio, coordinadora del programa y una de las pioneras en procuración de órganos en México.

“Fue cuando se pensó en enviarnos a prepararnos en la donación”.

La historia del trasplante pulmonar en México tiene cerca de 40 años, desde que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), de la Ciudad de México, realizó el primer caso exitoso en 1989.

El Hospital Universitario inició con Georgina Morales Hernández, “Goyita”, en 2003, procedimiento en el que participaron el neumólogo Chavarría, la enfermera De Osio, el anestesiólogo Fuentes Puga y otros especialistas.

Con ese procedimiento inició el primer programa formal de trasplante pulmonar en México, con resultados mixtos.

“Llegamos a tener el trasplante con mayor sobrevida en el País, de un paciente que vivió 11 años”, dice Chavarría.

“Y tuvimos varios éxitos, pero contados con los dedos



■ Manuel Wong (de izq. a der.), Uriel Chavarría, Vicente Fuentes Puga, Irma de Osio y Sergio Saúl Sánchez lideran el Programa de Trasplante Pulmonar.

Alejandro Garza

Su misión: devolver el aliento

Un equipo de médicos regiomontanos convirtió el trasplante pulmonar en México en una misión de vida que ha dado una segunda oportunidad a más de 50 pacientes

de una mano”.

Conforme avanzaba el tiempo, relata el médico, vieron que no contaban con la tecnología necesaria ni con la preparación en técnicas como el trasplante bipulmonar, que apuntaba a ofrecer mejores resultados.

Una esperanza llegó en 2009, cuando el neumólogo se enteró de la existencia de un cirujano de Nuevo León que, en esa época, se entrenaba en el Hospital Vall d'Hebron, de Barcelona, centro de referencia mundial en trasplantes de pulmón.

Era el doctor Wong, quien decidió especializarse en cirugía de tórax al ver el rezago tan grande que había en México y, conforme avanzó en su preparación, visualizó la posibilidad de adentrarse en el trasplante pulmonar.

Sus profesores extranjeros le advertían que no sería fácil por la falta de infraestructura de salud en el País.

“Me decían: ‘Manuel, de México han venido muchísimos, cientos. Nunca hacen nada. ¿Por qué tú vas a poder?’”, recuerda el cirujano, originario de Panamá y formado en la Universidad de Montemorelos.

“Y yo les respondía: ‘Ésa es la razón por la que vamos a triunfar, porque nosotros sabemos hacerlo a la mexicana”.

El neumólogo y el cirujano comenzaron a compartir sus sueños desde entonces, pero la falta de recursos e infraestructura en la región fue una de las razones por las que esos planes

tardaron años en materializarse.

Hacia 2015, cuando Wong estaba en Andorra terminando su doctorado, recibió la llamada del doctor Juan Galindo, quien entonces era director médico corporativo de Christus Muguerza y, junto con Chavarría, le tenía una propuesta.

Le dijo: “Estamos buscando un cirujano para trasplante pulmonar”.

Wong lo pensó mucho y, entre la muerte de su padre por cáncer, el deseo de estar cerca de su madre y el intenso frío que hacía en Andorra, tomó la decisión de volver.

Meses después, el primer caso del equipo atrajo reflectores y les dio credibilidad.

II

Horas antes del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos de 2025, el regío Juan Luis Flores Aguilar se convirtió en el paciente de mayor edad en México en recibir dos pulmones nuevos, a sus 66 años.

El hombre no sólo agradece una segunda oportunidad de vida, también reconoce la humanidad del equipo médico regio y su capacidad para sacarlo adelante cuando los pronósticos no eran favorables.

“Era un trasplante muy difícil por mi edad y porque antes tuve un infarto cerebral”, recuerda el ex entrenador de béisbol.

“Orábamos; el doctor Wong me decía que Dios me quería aquí”.

Su caso no ha sido el único de gran complejidad que ha tenido éxito.

Aquel trasplante de Mauricio Zapiain también destacó por ser el primero en México en utilizar Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO), un sistema que reemplaza temporalmente la función del corazón y los pulmones.

En ese primer caso se integró al equipo el neumólogo Sergio Saúl Sánchez, quien, de acuerdo con sus colegas, lleva la parte más pesada de todo el proceso.

“La mayor satisfacción es siempre ver que un paciente está feliz, que la familia está feliz y que, de pronto, recupera la vida”, comparte el médico.

“El mismo paciente te enseña que no demos por hecho una cosa tan sencilla como respirar”.

Otro caso destacado fue el del chiapaneco Luis Manuel García Moreno, quien se convirtió en 2020 en el primer trasplantado bipulmonar en América Latina tras haber sobrevivido al Covid-19.

Así, han tenido pacientes de Nuevo León, Oaxaca, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Durango, Quintana Roo y Baja California, con diferentes contextos, edades, enfermedades y pronósticos. Algunos no lograron salir con vida.

Detrás hay un equipo comprometido las 24 horas del día, sin importar si es domingo, Año Nuevo o si están agotados.

Porque un trasplante pulmonar no es cualquier cosa: es el procedimiento más complejo de todos los de su tipo y debe realizarse en una ventana de tiempo muy corta,

desde que se ofrece el órgano hasta que se coloca en su nuevo receptor.

“A veces las ofertas son en la noche o en la madrugada; no dormimos bien. Luego un equipo se traslada a cualquier parte del País, bajo el clima que sea y a la hora que sea”, explica Wong, coordinador quirúrgico del programa.

“Se hacen múltiples revisiones hasta el último momento y todo lo hacemos mediante llamadas telefónicas, videollamadas y mensajes de voz en tiempo real, de forma frenética durante 24 horas. Y después operamos”.

El anestesiólogo Fuentes añade: “Nos ha tocado que tenemos el trasplante, pero la vida sigue; tienes trabajo programado al día siguiente y debes continuar con tu rol”.

Así es esta vocación.

Y es algo que vivió muy de cerca Katerin Mares Cerda, cuyo procedimiento en 2021, a sus 14 años, fue el primero en un paciente pediátrico en México.

Sus pulmones llegaron cuando el cirujano estaba en el funeral de su madre, a miles de kilómetros de aquí.

“De inmediato vino para acá a mi cirugía”, cuenta Katerin, quien tras un pronóstico de muerte hoy goza de buena salud a sus 19 años. “Fue mucha dedicación a su profesión”.

El trasplante de Katerin se realizó pro bono, pues la familia no tenía los recursos para costearlo. Y así como ellos, otras familias han recibido apoyo del programa cuando no cuentan con un seguro médico que cubra el procedimiento.

El doctor Galindo, quien participó en el primer trasplante realizado en México en 1989, reconoce el compromiso total del equipo regio y asegura que el trabajo que han hecho es histórico para el País.

“Rompieron una serie de paradigmas que no se habían podido establecer”, asegura el médico.

“El primer trasplante doble de pulmón, el primer trasplante en una paciente pediátrica, el primer trasplante en un paciente con hipertensión pulmonar, el primer trasplante post Covid... Han logrado hitos increíbles en la medicina”.

III

Le pregunta el doctor Chavarría a Wong: “¿Has llorado por algún paciente?”.

El cirujano lo piensa unos instantes. “Nunca”, responde. “No me puedo dar ese lujo”.

Ha habido momentos difíciles, como la muerte de pacientes,

que los han hecho derrumbarse y replantearse si van por el camino correcto. Ahí se encargan de recordarse mutuamente su propósito de vida.

“Mi historia empieza cuando era niño y le pregunté a mi padre qué se estudiaba para ser doctor”, cuenta Chavarría.

“Y mi papá me explicó: ‘Esa carrera se cursa por vocación, y esa vocación debe llevarte a hacer cosas que no existen. Algo nuevo”.

Esa semilla germinó cuando descubrió el mundo del trasplante.

Porque esto va más allá de una cirugía: se convierte en una relación con el paciente y su familia que dura toda la vida.

Quienes reciben un órgano deben mantener seguimiento médico, estudios y medicamentos hasta sus últimos días.

La enfermera De Osio es quien más cerca está de ellos: los acompaña desde el primer contacto, les notifica de la llegada de órganos, está presente en sus logros y caídas, y no los suelta hasta el final.

“No sé si es el dolor de saber que su vida puede terminar muy pronto o la valentía de aceptar el desafío de una cirugía tan complicada”, dice la enfermera, de 78 años. “Lo cierto es que he conocido personas realmente extraordinarias”.

Todos los médicos del equipo continúan capacitándose de forma constante en diferentes hospitales y, con el tiempo, han visto cómo Monterrey empieza a destacar en congresos internacionales.

Aunque eso les llena de satisfacción, también les inquieta ser los únicos.

Entre las principales enfermedades que llevan a requerir un trasplante está el EPOC, que afecta al 10 por ciento de la población mexicana y cuyo incremento a nivel mundial se estima debido a la contaminación ambiental.

Se necesitan más programas y, por supuesto, más donaciones.

Mientras tanto, el equipo sigue trabajando, a veces ante la adversidad, recordando día con día su motivación.

“Yo estoy en el trasplante pulmonar como una misión de vida para generar un cambio”, subraya el cirujano Wong.

“A veces tenemos la idea de que tiene que venir algún europeo, norteamericano o alguien de un país muy desarrollado a enseñarnos cómo hacer las cosas. No. Latinoamérica lo puede hacer, y lo puede hacer muy bien”.



FAMILIA21

JESÚS AMAYA

familia21@elnorte.com

Aprender a sostenerse

EN las próximas semanas, en todas las universidades, tendremos las ceremonias de graduación de los nuevos profesionistas. Muchas felicidades a todos ellos y bienvenidos al mundo laboral.

Se enfrentarán a un escenario distinto al que enfrentaron sus

padres: más competitivo, más incierto y, a la vez, con una sensibilidad mucho mayor hacia la salud mental y el equilibrio en la vida. Ellos no desean reproducir el modelo del agotamiento que conocieron en casa, pero existe el riesgo de cambiarlo al extremo contrario: abandonar el primer conflicto, al jefe difícil o la

tarea aburrida o frustrante.

Hoy sabemos, y distintos estudios lo confirman, que una proporción considerable de jóvenes de esta generación piensa dejar su trabajo en el primer año. Algunos informes indican que entre un tercio y casi la mitad de los trabajadores de la Generación Z piensan en renunciar inminente, sobre todo como consecuencia de la falta de crecimiento, el mal clima laboral o la falta de encaje con sus valores.

Al mismo tiempo, manifiestan niveles elevados de estrés, ansiedad y preocupación por su salud mental, de modo que cualquier incidencia laboral puede desbordar sus capacidades hasta el punto de considerarla insoportable.

La queja no proviene de la “pe-reza”, sino que han crecido viendo a sus padres llegar a casa agotados por el trabajo, con poco tiempo para la familia o con problemas de salud derivados de la jornada laboral. Escucharon frases como “así es la vida” o “hay que aguantar”, y por eso no quieren repetir esa historia.

Sin embargo, ese deseo de equilibrio corre el riesgo de que el péndulo se desplace al extremo opuesto. Cuando “cuidar mi bienestar” se convierte en “salir corriendo ante el primer conflicto, crítica o frustración”, el joven se ve privado de la posibilidad de desarrollar la musculatura emocional que solo se forja ante retos reales. Y aquí conviene recordar-

les una idea clave: no existe el primer trabajo perfecto.

Los primeros empleos casi siempre incluyen tareas aburridas, jefes poco comprensivos, horarios incómodos y responsabilidades que parecen excesivas. Al atravesar estas experiencias, se desarrollan capacidades esenciales: disciplina, tolerancia a la frustración, manejo de la autoridad, organización del tiempo, constancia y habilidad para trabajar en equipo.

Además de escuchar con atención, los padres pueden seguir desarrollando tres competencias en sus hijos recién graduados. La primera es la tolerancia a la frustración: recordarles que casi ningún primer trabajo

remunerado es el trabajo soñado, pero sí una excelente escuela para aprender disciplina, responsabilidad y constancia.

La segunda es la mentalidad de crecimiento: ayudarles a entender que equivocarse o recibir correcciones no es un ataque a su valor personal, sino información para mejorar.

Y la tercera es la perseverancia con propósito: invitarles a fijarse metas de tiempo, por ejemplo, permanecer entre 6 y 12 meses en una misma empresa mientras aprenden habilidades concretas y, después de ese periodo, evaluarse con calma para decidir si es momento de buscar otra oportunidad.